Boîte à outils pour les AVC v3.0

Instruments

Objectif de la boîte à outils

Un ensemble de normes de collecte de données visant à recueillir les phénotypes essentiels associés à la recherche biomédicale liée aux AVC, telles que déterminées à l'origine par le groupe de travail sur l'harmonisation des phénotypes H3Africa et H3AbioNet et poursuivies dans leur développement par l'African Genomics Data Hub (AfriGen -D).

Description des lignes directrices

La boîte à outils sur les AVC peut être utilisée pour recueillir des données phénotypiques essentielles pour la recherche sur les AVC, notamment : la caractérisation des AVC et la vérification des AVC, ainsi que la prévention primaire et secondaire. Le document suivant établit des lignes directrices (particulièrement applicables en Afrique) sur l'utilisation de cette boîte à outils et la collecte de données phénotypiques et d'exposition détaillées, pertinentes et harmonisées pour la recherche.

Comme indiqué ci-dessous, la boîte à outils sur les AVC se compose de 3 instruments, étiquetés **Instruments 1 à 3 :**

Instrument	**Phénotypes**
1	Caractérisation des AVC
2	Stratégies de réduction des risques avant un AVC
3	Stratégies de réduction des risques après un AVC

Remarques importantes

1. Cette boîte à outils utilise une logique de branchement ; par conséquent, nous recommandons de la compléter dans l'ordre, car certaines variables peuvent apparaître ou non, ou accepter des entrées en fonction des entrées des variables précédemment listées.

2. Certaines logiques de branchement (notamment liées à la date de naissance/ à l'âge et au sexe biologique) affectent l'affichage des éléments pertinents pour les participants adultes ou pédiatriques dans plusieurs instruments.

3. Toute modification ou suppression de variables peut également affecter la logique de branchement ; il convient donc de positionner soigneusement les modifications apportées aux variables afin de ne pas interrompre les conditions de la logique de branchement avec des variables liées.

4. Il est recommandé d'utiliser cette boîte à outils conjointement avec la boîte à outils Core Phenotypes (https://github.com/h3abionet/h3aphenstds).

5. Bien que cela ne soit pas indiqué ci-dessous, chaque instrument nécessite une date de collecte , qui peut être enregistrée manuellement ou automatiquement.

6. L'utilisation de codes cohérents est recommandée pour l'identification des données manquantes, et ceux-ci sont intégrés dans tous les instruments présentés ci-dessous.

7. Les codes relatifs aux données manquantes sont spécifiés ci-dessous :

Code	Étiquette de valeur
-991	Aucune information
-992	Demandé mais inconnue
-993	Temporairement indisponible
-994	Non demandé
-995	Refusé
-998	Non applicable

8. Nous recommandons, lorsqu'un participant répond « Je ne sais pas » à une question, que l'intervieweur s'assure d'abord que le participant a bien compris la question, puis l'encourage , si possible, à reconsidérer sa réponse. Si la réponse reste « Je ne sais pas », nous utilisons le code « Demandé mais inconnu e ». Pour les questions où « Je ne sais pas » est une réponse courante et valide, une case à cocher « Inconnu » sera ajoutée ; il est important de noter que cette réponse ne sera pas considérée comme une donnée manquante par les logiciels statistiques.

9. Les traductions intégrées à partir de la version 3.0 permettent aux collecteurs de données utilisant REDCap de basculer entre les versions traduites des instruments – veuillez consulter la documentation supplémentaire sur la mise en œuvre et l'utilisation des traductions.

Recommandations

Instrument 1 : Caractérisation de l'AVC

Cet instrument permet de recueillir des informations relatives au statut d'AVC et à la caractérisation des participants à la recherche, ainsi que leur vérification.

Questions	Le participant est-il actuellement victime d'un AVC ? **Options de réponse** : Oui ; Non (Si oui) Quel côté du corps est affecté ? **Options de réponse** : Droit ; Gauche ; Les deux (Si oui) Quel était le statut d'incapacité du participant après l'AVCl le plus récent ? **Options de réponse** : Aucun symptôme ; aucune incapacité significative ; incapacité légère ; incapacité modérée ; incapacité modérément sévère ; incapacité sévère Comment l'AVC a-t-il été confirmé ? **Options de réponse** : Scanner ; IRM ; Angiographie ; Non vérifié Quand le premier examen d'imagerie a-t-il été effectué après l'apparition des symptômes de l'AVC ? **Options de réponse** : Dans les 24 heures ; 24 à 48 heures ; 48 à 72 heures ; 72 heures à 1 semaine ; 1 à 2 semaines ; Après 2 semaines L'épisode d'AVC le plus récent était-il un accident ischémique transitoire ? **Options de réponse** : Oui ; Non ; Non évalué Faiblesse faciale détectée/observée : **Options de réponse** : Oui ; Non ; Non évalué
Notes	- **Accident vasculaire cérébral (AVC)** - Altération soudaine du flux sanguin vers une partie du cerveau due à l'occlusion ou à la rupture d'une artère cérébrale. - **Accident ischémique transitoire (AIT)** - Une brève crise (de quelques minutes à une heure) de dysfonctionnement cérébral d'origine vasculaire, sans déficit neurologique persistant. - Définition **des niveaux de gravité de l'incapacité …** - **Aucune incapacité significative** - Capable d'effectuer toutes les activités habituelles, malgré certains symptômes d'AVC. - **Incapacité légère** – Capable de gérer ses affaires sans assistance, mais incapable d'effectuer toutes les activités antérieures. - **Incapacité modérée** – Nécessite une certaine aide, mais peut marcher sans assistance. - **Incapacité modérément sévère -** Incapable de répondre à ses propres besoins corporels sans assistance et incapable de marcher sans aide. - **Incapacité sévère** – Nécessite des soins infirmiers et une attention constants, alité, incontinent.

Questions	Type d'AVC : **Options de réponse** : Ischémique ; Hémorragique ; Ischémique avec transformation hémorragique ; Transformation ischémique et hémorragique distincte Localisation de la lésion : (Si ischémique) Classification OSCP **Options de réponse** : TACI; PACI; POCI; LACI [(Si ischémique) Classification ASCOD] athérosclérose maladie des petits vaisseaux Cardioembolie Autres causes Dissection] **Options de réponse** : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 9
Notes	- **Ischémique** : Un accident vasculaire cérébral (AVC) survient lorsque le flux sanguin dans l'artère qui alimente le cerveau en sang oxygéné est bloqué. - **Hémorragique** : Un accident vasculaire cérébral (AVC) qui survient lorsqu'une artère du cerveau se rompt (laisse échapper du sang). Le sang qui s'échappe exerce une pression excessive sur les cellules cérébrales, ce qui les endommage. - **Classification OSCP :** - TACI : infarctus total de la circulation antérieure - PACI : infarctus partiel de la circulation antérieure - POCI : infarctus de la circulation postérieure - LACI : infarctus lacunaire - **Classification ASCOD** : évaluez la gravité de CHAQUE cause ci-dessous (chacun des 5 phénotypes peut être évalué à 1, 2 ou 3). - **Artériosclérose** - Maladie caractérisée par un épaississement de la paroi des petites artères et des artérioles, causé par le dépôt de matériel hyalin dans la paroi ou par une hypertrophie concentrique de la paroi musculaire lisse, et qui entraîne un rétrécissement de la lumière vasculaire et une ischémie tissulaire. - **Maladie des petits vaisseaux** : processus pathologiques affectant la circulation parenchymateuse cérébrale (artérioles, capillaires et veines). Elle contribue fortement aux AVC et constitue une cause majeure de troubles cognitifs et de démence. - **Cardioembolie** - Embolie résultant d'une obstruction d'un vaisseau cardiaque due à un caillot sanguin ou à d'autres substancesétrangères. - **Dissection** - Le processus consistant à découper ou à séparer des tissus, par exemple dans le cadre d'une étude anatomique ou lors d' une intervention chirurgicale. - **Autre cause** - Autres causes n'incluant pas les quatre susmentionnées .

Instrument 2 : Stratégies de réduction des risques avant l'AVC

Cet instrument permet de recueillir des informations autodéclarées relatives à l'utilisation de stratégies de prévention des AVC chez les personnes n'ayant jamais subi d'AVC auparavant.

Questions	Le participant a-t-il déjà utilisé des stratégies de réduction des risques pour prévenir un AVC ? **Options de réponse** : Oui ; Non (Si oui) Précisez les stratégies de réduction du risque d'AVC mises en œuvre : **Options de réponse** : Antiarythmiques ; Traitement anticoagulant ; Antidiabétiques ; Traitement antihypertenseur ; Hypolipémiants ; Traitement antiplaquettaire ; Sevrage tabagique ; Changements alimentaires ; Changements d'activité physique ; Traitement par statines ; Intervention chirurgicale ; Autre (Si autre) Précisez les autres stratégies de réduction du risque d'AVC mises en œuvre :
Notes	- **Antiarythmiques** - Médicaments utilisés pour traiter les troubles du rythme cardiaque résultant d'une activité électrique irrégulière du cœur. - **Anticoagulants** - Médicaments capables de prévenir la formation de caillots sanguins. - **Antidiabétiques** - Médicaments qui permettent de réduire les taux anormalement élevés de glucose (sucre) dans le sang. - **Antihypertenseurs** - Médicaments utilisés dans le traitement de l'hypertension aiguë ou chronique,indépendamment de leur mécanisme pharmacologique. - **Hypolipémiants** - Les agents hypolipémiants, également appelés médicaments réduisant le cholestérol ou agents antihyperlipidémiques, constituent un groupe diversifié de produits pharmaceutiques utilisés pour abaisser le taux de lipides et de lipoprotéines, comme le cholestérol, dans le sang. - **Antiplaquettaires** - Médicaments qui empêchent les cellules sanguines (plaquettes) de s'agglomérer et de former un caillot. - **Statines** - Une classe de médicaments utilisés pour réduire le cholestérol. - **Sevrage tabagique** - Arrêt de l'habitude de fumer.

Instrument 3 : Stratégies de réduction des risques après un AVC

Cet instrument permet de recueillir des informations autodéclarées relatives à la mise en œuvre de stratégies de prévention des AVC chez les personnes ayant déjà subi un AVC.

Questions	Le participant a-t-il déjà utilisé des stratégies de réduction des risques après un AVC ?

	Options de réponse : Oui ; Non (Si oui) Précisez les stratégies de réduction des risques post-AVC mises en œuvre : **Options de réponse** : Antiarythmiques ; Traitement anticoagulant ; Antidiabétiques ; Traitement antihypertenseur ; Hypolipémiants ; Traitement antiplaquettaire ; Sevrage tabagique ; Changements alimentaires ; Changements d'activité physique ; Traitement par statines ; Intervention chirurgicale ; Autre (Si autre) Précisez les autres stratégies de réduction des risques post-AVC mises en œuvre :
Notes	- **Voir les notes de l'instrument 2** pour plus d'explications sur les stratégies de réduction des risques incluses.

Abréviations

ASCOD : Athérosclérose, maladie des petits vaisseaux, source cardiaque, autre cause, dissection
Scanner : tomodensitométrie
LACI : Infarctus lacunaire
IRM : Imagerie par résonance magnétique
OSCP : Projet communautaire de lutte contre les AVC dans l'Oxfordshire
PACI : Infarctus partiel de la circulation antérieure
POCI : Infarctus de la circulation postérieure
TACI : Infarctus totale de la Circulation Antérieure
AIT : accident ischémique transitoire

Administration

Mode d'administration

	Instruments		
	1	2	3
Entretien OU questionnaire auto-administré	X	X	X

Évaluation clinique	X		
Évaluation par bioessai/en laboratoire			

Étape de la vie

	Instruments		
	1	2	3
Nourrisson (0 - 12 mois)			
Enfant en bas âge (13 à 24 mois)			
Enfance (2 - 11 ans)			
Adolescence (12 - 18 ans)			
Adulte (18 ans et plus)	X	X	X

Personnel et formation requis

L'instrument 1 doit être administré par du personnel de santé qualifié et expérimenté, ou les informations doivent être extraites de leurs dossiers. Les informations peuvent également provenir des dossiers hospitaliers et/ou des dossiers patients. **Les instruments 2 et 3** peuvent être utilisés sous forme de questionnaires auto-administrés ou de questionnaires administrés par un enquêteur. Dans ce dernier cas, les entretiens doivent être menés par des coordinateurs d'étude ou des collecteurs de données formés et maîtrisant la langue maternelle/locale de la population cible.

Références

La boîte à outils sur les AVC s'appuie sur plusieurs normes existantes et s'y aligne afin de faciliter l'harmonisation des données . Ces ressources sont énumérées ci-dessous :

1. Formulaires de rapport de cas SIREN H3Africa (CRF)

Contributeurs

Après 2024
Projet AfriGen -D CRF Stds et REDCap

Avant 2024
Groupe de travail sur l'harmonisation des phénotypes - H3Africa
Projet conjoint d'harmonisation des phénotypes - H3ABioNet

Projet de standardisation des phénotypes - H3ABioNet
Faniyan Moyinoluwalogo
Judit Kumuthini
Lyndon Zass
Mayowa Owolabi
Melek Chaouch
Michael Thompson
Paul Olowoyo

Contactez-nous

Pour toute question relative à cette norme et à ces lignes directrices, les utilisateurs peuvent ouvrir un ticket auprès du service d'assistance AfriGen -D (Data Collection Toolkits). Les retours des utilisateurs et suggestions d'amélioration concernant le kit d'outils actuel sont encouragés. Ceux-ci peuvent également être soumis via le service d'assistance ou dans les sections « Issues » et « Discussion » de notre dépôt GitHub .